

Estratificación de **riesgo** farmacológico en síndrome metabólico

Modelo predictivo basado en datos de dispensación farmacéutica

ALEJANDRO SANZ SERRANO
FARMACÉUTICO | ANALISTA DE DATOS

Problema clínico y oportunidad

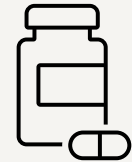
- Alta prevalencia de síndrome metabólico
- Polimedicación frecuente
- **Dificultad** para identificar pacientes de riesgo
- Falta de herramientas de priorización



No todos los pacientes presentan el mismo riesgo de intensificación terapéutica

Datos y población de estudio

- Datos anonimizados de dispensación farmacéutica (RWD)
- Pacientes en tratamiento para:
 - Hipertensión
 - Diabetes
 - Dislipemia
- Identificación mediante ID anónimo
- **Variables derivadas:**
 - Número de grupos terapéuticos
 - Intensificación del tratamiento



Los datos permiten aproximar la complejidad terapéutica del paciente en entorno real

Enfoque analítico

- Modelo de clasificación y predicción, interpretable y **alineado con la práctica clínica**
- Objetivo: predecir la intensificación del tratamiento
- Variable objetivo:
 - 1 → intensificación
 - 0 → no intensificación
- Variables explicativas:
 - Número de grupos terapéuticos
 - Presencia de HTA, diabetes y dislipemia

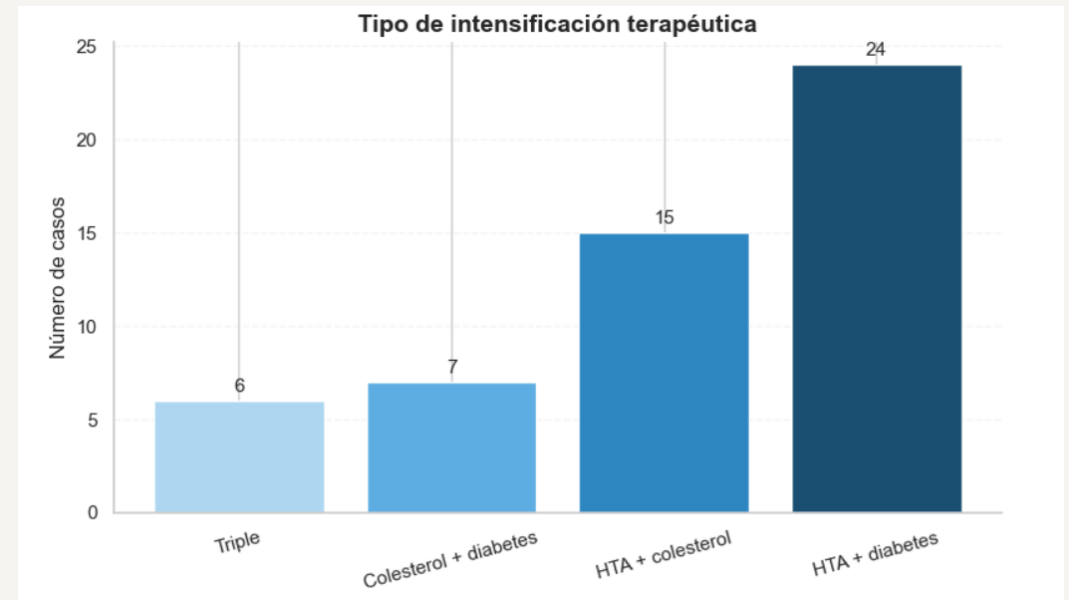


Enfoque centrado en el paciente, orientado a la priorización de riesgo

Resultados clave

- El riesgo de intensificación aumenta con la carga terapéutica
- Pacientes con múltiples patologías presentan mayor riesgo
- La hipertensión es la patología más común al inicio del proceso
- La diabetes actúa como **principal factor de progresión**
- El modelo permite identificar pacientes de alto riesgo antes de cambios terapéuticos

EL RIESGO NO DEPENDE DE UNA ÚNICA PATOLOGÍA, SINO DE LA ACUMULACIÓN DE FACTORES



Conclusiones y aplicación

- La intensificación terapéutica puede utilizarse como indicador de progresión clínica
- La complejidad del paciente es el principal determinante del riesgo
- Es posible identificar pacientes de alto riesgo a partir de datos de dispensación
- **El modelo permite priorizar seguimiento e intervención farmacéutica**
- Limitaciones: ausencia de datos clínicos y dependencia de datos de dispensación

	hta	colesterol	diabetes	n_grupos	target	probabilidad	pred
294	True	True	True	3	0	0.915696	1
98	True	True	True	3	0	0.915696	1
141	True	True	True	3	0	0.915696	1
277	True	True	False	2	0	0.802129	1
10	True	True	False	2	0	0.802129	1

ENFOQUE PROACTIVO CENTRADO EN EL PACIENTE COMO
COMPLEMENTO A LA FARMACOVIGILANCIA TRADICIONAL